

HEALTH CARE REPORT



Tên dự án	Health-care	Reporting Period
Người báo cáo	Nguyễn Mạnh Cường	Jan 19, 2026 to Jan 22, 2026

MỤC TIÊU

- Cung cấp tầm nhìn tổng quan về tình hình chăm sóc sức khỏe tại Mỹ
- Phân tích các phản hồi của bệnh nhân dựa trên 10 tiêu chí survey
- Cung cấp các giải pháp xử lý vấn đề tồn đọng

MỤC LỤC

- Tổng quan về data set
- Báo cáo, phân tích tình hình health-care tại quy mô quốc gia
- Báo cáo, phân tích tình hình health-care tại quy mô các bang
- Các giải pháp đề xuất

TỔNG QUAN VỀ DATA-SET

Data-set “HCAHPS (2013–2022) – bộ khảo sát trải nghiệm bệnh nhân tại Mỹ” là tập data về mảng chăm sóc y tế của Mỹ được thu thập bằng cách khảo sát các bệnh nhân tại các cơ sở y tế của 50 bang. Mỗi bệnh nhân ngay trước khi ra viện sẽ được cung cấp 1 mẫu khảo sát bao gồm 10 đề mục, mỗi mục sẽ có từ 1–3 câu hỏi nhằm khảo sát các khía cạnh về dịch vụ chăm sóc y tế khi ở bệnh viện. Khảo sát được tiến hành trên khoảng 5000 cơ sở y tế trên toàn nước Mỹ trong khoảng thời gian từ 01/10/2013 – 30/09/2022.

Nội dung của khảo sát tập trung vào 10 khía cạnh dịch vụ của các cơ sở đối với bệnh nhân nhằm đánh giá sự hài lòng của người bệnh trong thời gian nằm viện như: tương tác với y tá, tương tác với bác sĩ, sự hỗ trợ của các nhân viên khi nằm viện ... Các đánh giá khác về cơ sở vật chất, điều trị sẽ không bao gồm trong khảo sát.

Thông qua data-set này, người đọc sẽ có thông tin tổng quan về chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế tại các bệnh viện trên toàn nước mỹ cũng như chi tiết chất lượng của từng bang theo đánh giá của chính bệnh nhân. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng data-set này không thể đánh giá toàn diện về chất lượng dịch vụ và càng không thể làm thước đo đánh giá các cơ sở y tế đang làm tốt hay không. Do vậy, với mỗi đánh giá trong phần phân tích báo cáo, hãy hiểu rằng đánh giá đó là dành riêng cho khía cạnh dịch vụ được đưa vào khảo sát.

Các chỉ số được khảo sát:

1. H_COMP_1: Tương tác với y tá
2. H_COMP_2: Tương tác với bác sĩ
3. H_COMP_3: Sự hỗ trợ của nhân viên khi bệnh nhân cần
4. H_COMP_5: Hỗ trợ thông tin toa thuốc
5. H_COMP_6: Cách chăm sóc sức khỏe khi xuất viện
6. H_COMP_7: Hỗ trợ thông tin khi xuất viện/chuyển viện
7. H_CLEAN_HSP: Tình trạng vệ sinh tại bệnh viện
8. H_QUIET_HSP: Mức độ ồn tại bệnh viện
9. H_HSP_RATING: Đánh giá chung về bệnh viện
10. H_RECMND: Sẵn sàng giới thiệu bệnh viện cho người thân

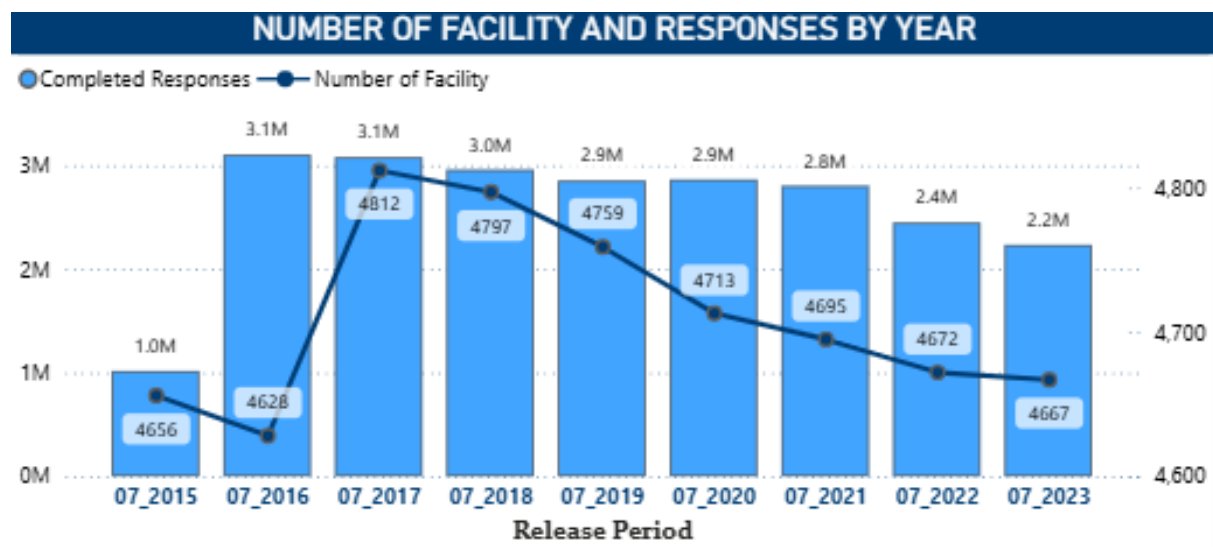
BÁO CÁO - PHÂN TÍCH

1. Báo cáo tổng quan trên quy mô toàn quốc

1.1 Số lượng khảo sát theo từng năm

Trong khoảng thời gian từ 01/10/2013 – 30/09/2022 (9 năm), khảo sát được tiến hành, có:

- 50/50 bang tham gia
- Gần 5000 cơ sở y tế tham gia
- Hơn 23 triệu lượt phản hồi từ bệnh nhân
- Trung bình 500 phản hồi/1 cơ sở y tế.



Bảng: số lượng phản hồi và cơ sở y tế tham gia khảo sát theo năm

Ngoại trừ năm đầu tiên: 2015 mới triển khai, từ 2016–2023 số lượng phản hồi từ bệnh nhân và số lượng các cơ sở y tế tham gia khảo sát ngày càng giảm.

- Số lượng phản hồi giảm 30% từ: 3.1 triệu (2016) giảm còn 2.2 triệu (2023)
- Số lượng cơ sở tham gia khảo sát giảm 151 từ: 4812 (2017) giảm còn 4661 (2023)

Ngoài ra, có khoảng 40% các bang có các cơ sở y tế không đạt trung bình 500

response/năm (1.5 response/ngày) và cá biệt có các bang không hề tham gia vào khảo sát (0 responses)

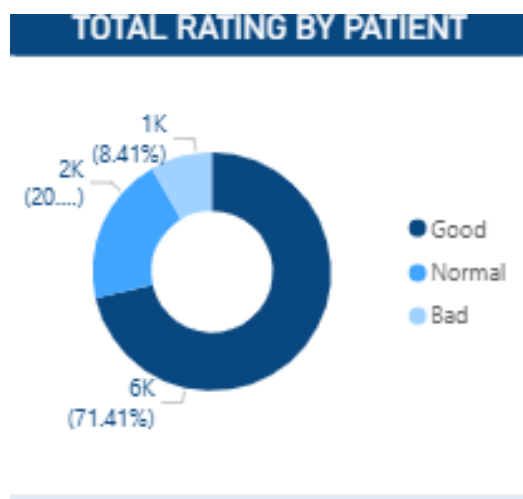
RESPONSES BY STATE																		
Release Period	AK	AL	AR	AS	AZ	CA	CO	CT	DC	DE	FL	GA	GU	HI	IA	ID	IL	IN
07_2015	145.24	226.70	191.33		235.53	258.98	191.56	270.00	262.50	300.00	275.41	219.23	0.00	205.56	153.18	160.98	237.78	239.84
07_2016	393.50	701.63	536.58		956.14	1,014.71	819.64	980.87	976.63	761.17	1,326.31	590.50	0.00	791.72	290.76	461.17	763.64	615.68
07_2017	282.18	642.23	525.99	0.00	886.58	1,006.55	665.45	910.29	1,092.50	578.14	1,327.87	565.55	0.00	558.96	281.74	474.17	740.65	618.08
07_2018	298.91	595.40	515.23	0.00	806.62	939.69	639.08	898.13	1,031.63	587.71	1,331.15	563.32	0.00	544.96	280.17	384.05	722.75	628.12
07_2019	258.55	600.57	472.55	0.00	729.69	930.76	633.06	861.22	838.33	572.25	1,305.46	551.31	0.00	555.61	267.79	363.16	695.92	578.21
07_2020	290.77	580.66	457.75	0.00	721.97	940.21	639.07	887.42	830.88	590.25	1,339.80	567.41	0.00	547.75	289.65	395.16	612.71	565.99
07_2021	270.82	573.24	463.71	0.00	686.26	939.83	624.91	879.23	800.38	585.88	1,309.72	537.90	0.00	533.08	294.99	383.45	581.16	566.35
07_2022	194.36	589.36	342.05	0.00	649.53	832.76	410.27	838.90	1,286.38	518.75	1,048.79	415.57	0.00	476.42	252.01	328.05	547.46	478.47
07_2023	163.64	570.25	325.31	0.00	526.90	706.03	366.12	694.35	903.38	465.00	1,008.99	401.84	0.00	428.92	211.09	237.75	518.88	434.58
Total	2,067.63	4,737.41	3,599.27	0.00	5,364.14	7,092.20	4,566.47	6,982.59	7,224.33	4,548.13	9,573.51	4,160.74	0.00	4,324.50	2,277.10	3,010.09	5,278.88	4,415.29

Bảng: Trung bình responses theo bang

1.2 Chất lượng dịch vụ theo đánh giá của bệnh nhân

Theo đánh giá của bệnh nhân qua các năm:

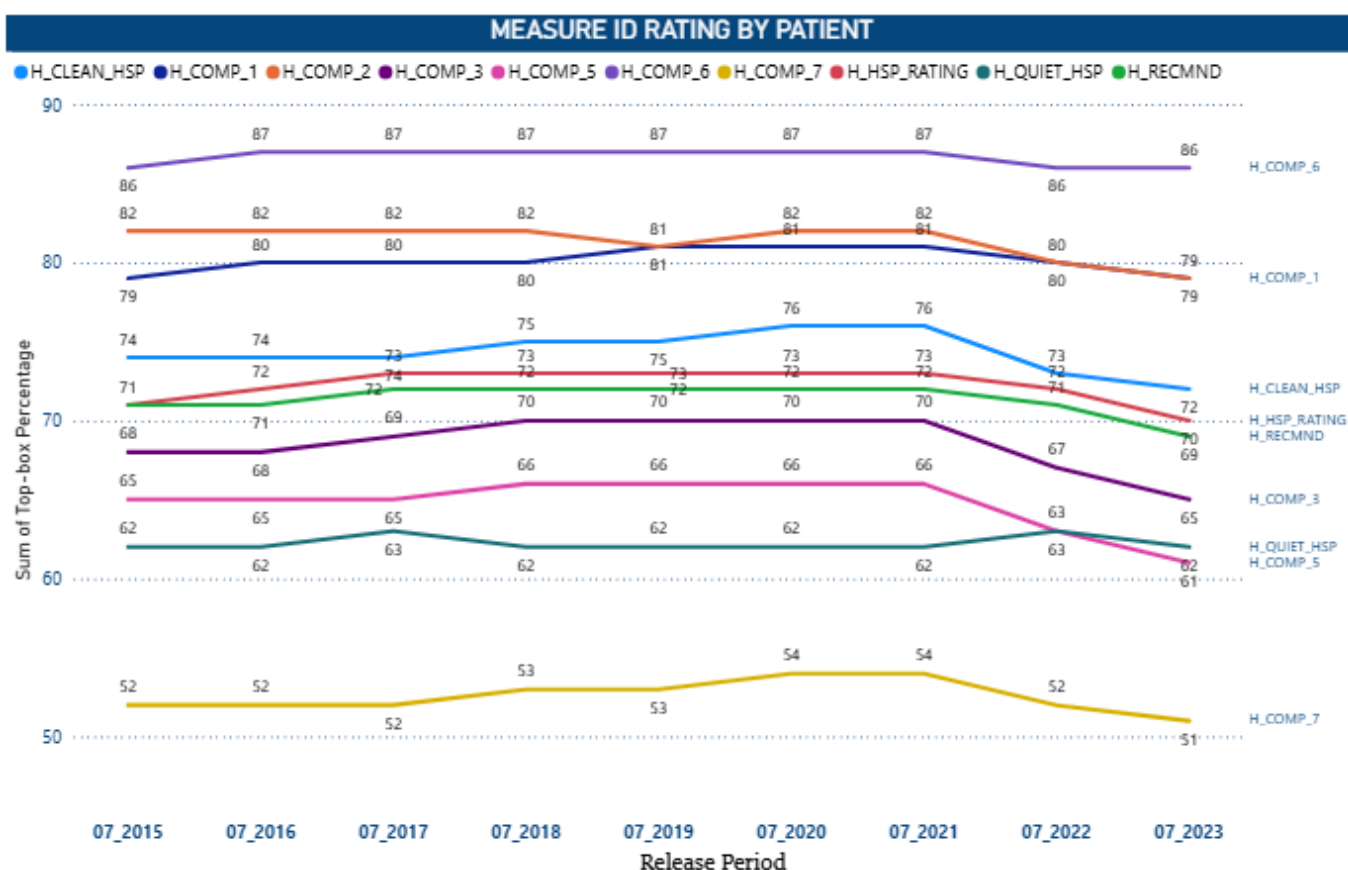
- Dịch vụ ở mức tốt: 70%
- Dịch vụ ở mức trung bình: 20%
- Dịch vụ ở mức tệ: 10%



Bảng: Đánh giá của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ

Đây là tín hiệu tương đối tốt khi luôn có 70% người dùng hài lòng với dịch vụ của bệnh viện trong 9 năm tiến hành khảo sát.

1.3 Đánh giá chung về 10 chỉ số



Bảng: Phần trăm đánh giá 10 chỉ số qua các năm (Good rating)

Nhìn chung, 9/10 tiêu chí (trừ H-COMP6) đều đang có xu hướng giảm nhẹ trong 2 năm 2022-2023, đây là 1 tín hiệu tuy chưa mang tính tiêu cực, nhưng vẫn cần lưu ý.

Top 3 các chỉ số được đánh giá cao nhất:

- Cách chăm sóc sức khỏe khi xuất viện (trung bình 85%)
- Tương tác với bác sĩ (trung bình 80%)
- Tương tác với y tá (trung bình 80%)

Top 3 các chỉ số được đánh giá kém nhất:

- Hỗ trợ thông tin khi xuất viện/chuyển viện (trung bình 52%)
- Mức độ ồn tại bệnh viện (trung bình 62%)
- Hỗ trợ thông tin toa thuốc (trung bình 65%)

1.4 Đánh giá chung

1.Số lượng các cơ sở y tế tham gia khảo sát và số lượng phản hồi nhận được đang có xu hướng giảm rõ rệt và có khoảng 40% cơ sở y tế không đạt trung bình 500 response/năm. Điều này chứng tỏ các cơ sở y tế không còn tích cực triển khai khảo sát bệnh nhân nữa.

2.Trong 10 tiêu chí đánh giá, có đến 9 tiêu chí đang có xu hướng giảm nhẹ trong 2 năm liền, đây là tín hiệu bệnh nhân bắt đầu có sự không hài lòng với dịch vụ nói chung tại các cơ sở y tế. Tuy chưa cấp thiết nhưng là tín hiệu rất đáng quan tâm.

3.Với 3 tiêu chí được đánh giá thấp nhất, ngành y tế cần có bộ tiêu chuẩn cũng như phương pháp đào tạo để nhân sự tại bệnh viện có thể nâng cao chất lượng dịch vụ trong tư vấn cho bệnh nhân về thông tin toa thuốc và hỗ trợ khi chuyển viện. 3 tiêu chí này sẽ được phân tích kĩ hơn theo state ở phần sau

Ngoài ra, với vấn đề bệnh nhân phản ánh mức độ ồn trong viện, cần có khảo sát chuyên sâu hơn về nguyên nhân gây ra tiếng ồn:

- Nếu đến từ bên ngoài bệnh viện, cần có report lên chính quyền địa phương gần nhất.

- Nếu đến từ bên trong bệnh viện, cần có nội quy/quy định giảm tiếng ồn trong khi làm việc tại viện.

2.Báo cáo theo Bang

Trong phần 2 của báo cáo, chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích 3 chỉ số đang bị các bệnh nhân đánh giá tệ nhất:

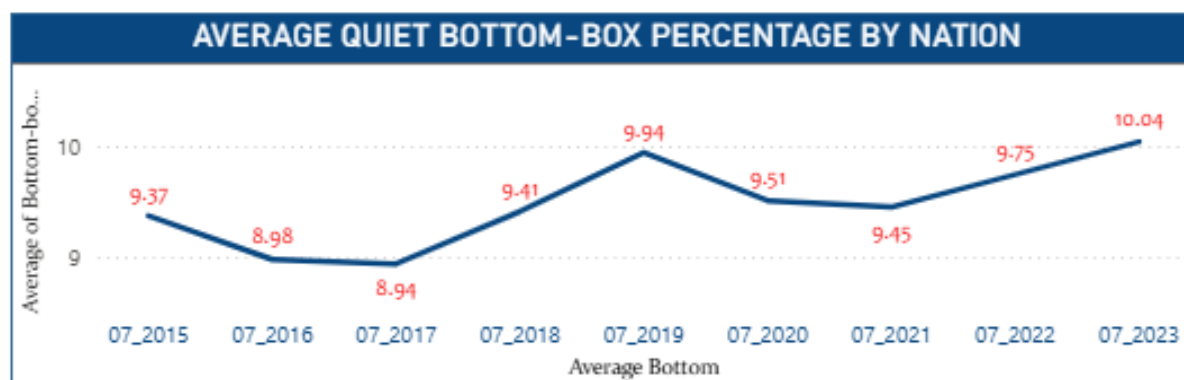
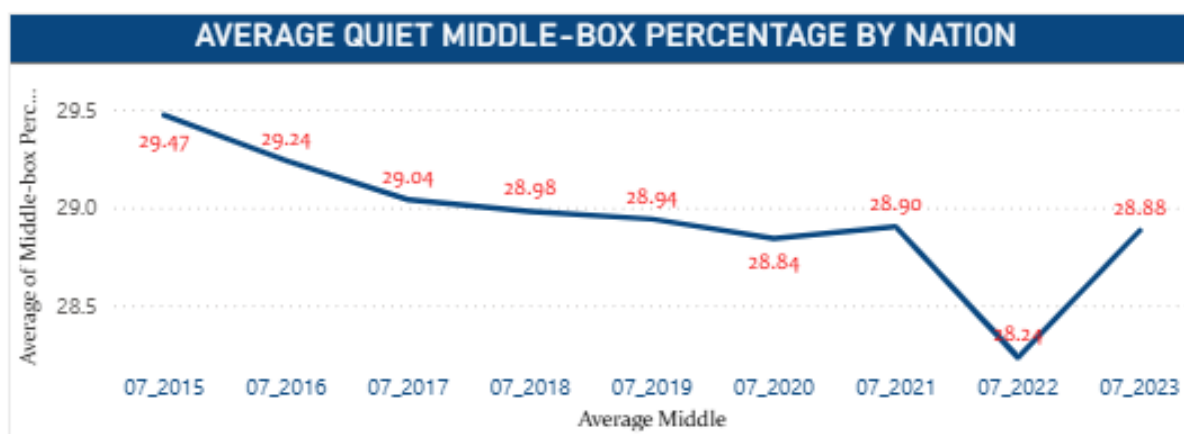
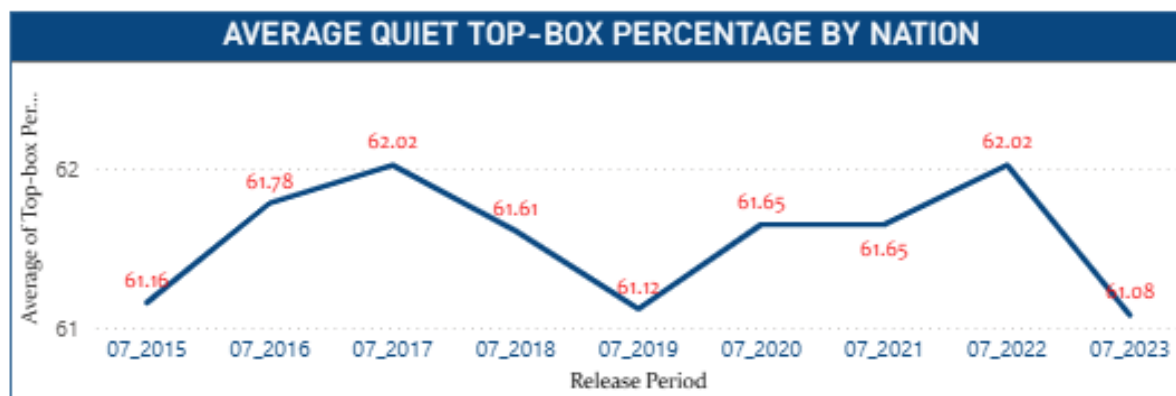
- H_QUIET_HSP: Mức độ ồn tại bệnh viện

- H_COMP_5: Hỗ trợ thông tin toa thuốc

- H_COMP_7: Hỗ trợ thông tin khi xuất viện/chuyển viện

2.1 H_QUIET_HSP: Mức độ ồn tại bệnh viện

Theo đánh giá hàng năm từ bệnh nhân, chỉ có khoảng 60% responses cho rằng họ không bị làm phiền bởi tiếng ồn vào ban đêm. Khoảng 30% cho rằng thì thoảng họ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và 10% thường xuyên nghe thấy tiếng ồn vào ban đêm.



Bảng: Đánh giá trung bình tiếng ồn vào ban đêm

Tiếng ồn là 1 trong 3 chỉ số bị đánh giá tệ nhất, tuy nhiên tại 1 vài bang, chỉ số

này còn thấp hơn trung bình và cần khắc phục ngay

AVERAGE TOP-BOX PERCENTAGE BY STATE						
Release Period	CA	CT	DC	MA	NJ	NY
07_2015	52	52	54	52	53	52
07_2016	51	52	54	53	53	52
07_2017	52	53	53	52	54	53
07_2018	52	54	56	52	53	53
07_2019	51	54	55	51	53	52
07_2020	51	55	56	51	52	53
07_2021	51	53	56	51	52	53
07_2022	52	52	57	51	54	54
07_2023	50	51	54	50	52	52

Bảng: Đánh giá tích cực về tiếng ồn theo các bang

AVERAGE MIDDLE-BOX PERCENTAGE BY STATE						
Release Period	CA	CT	DC	MA	NJ	NY
07_2015	32	33	30	33	32	33
07_2016	33	33	30	33	32	34
07_2017	32	33	31	34	31	32
07_2018	32	32	28	34	32	32
07_2019	33	32	27	34	32	33
07_2020	33	32	27	35	33	32
07_2021	33	33	28	35	33	33
07_2022	32	33	27	34	31	31
07_2023	33	34	30	33	32	32

Bảng: Đánh giá trung bình về tiếng ồn theo các bang

AVERAGE BOTTOM-BOX PERCENTAGE BY STATE						
Release Period	CA	CT	DC	MA	NJ	NY
07_2015	16	15	16	15	15	15
07_2016	16	15	16	14	15	14
07_2017	16	14	16	14	15	15
07_2018	16	14	16	14	15	15
07_2019	16	14	18	15	15	15
07_2020	16	13	17	14	15	15
07_2021	16	14	16	14	15	14
07_2022	16	15	16	15	15	15
07_2023	17	15	16	17	16	16

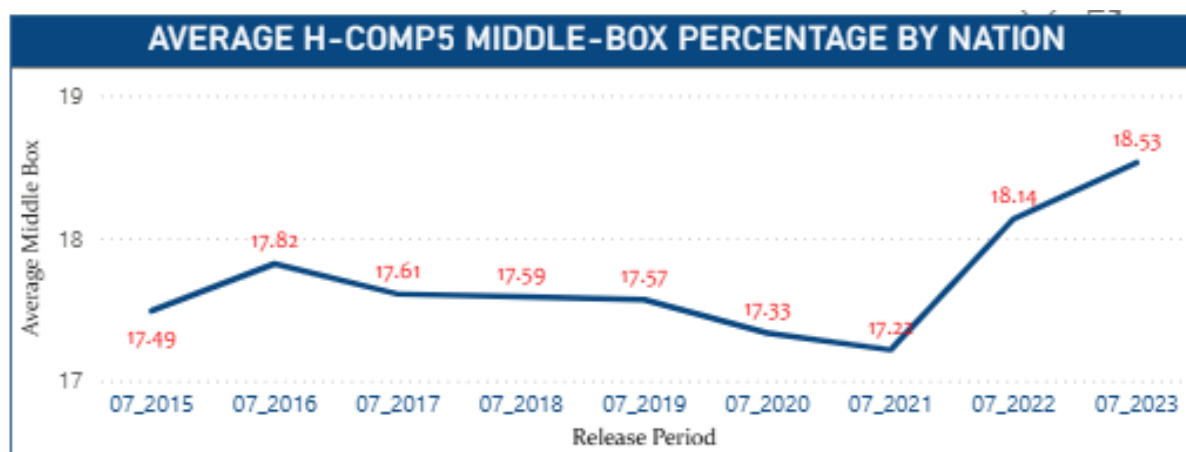
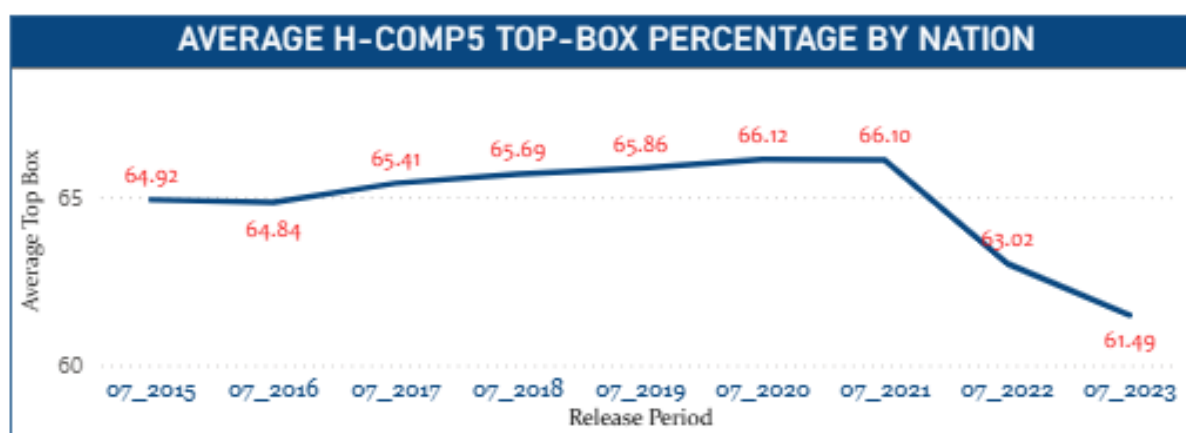
Bảng: Đánh giá tiêu cực về tiếng ồn theo các bang

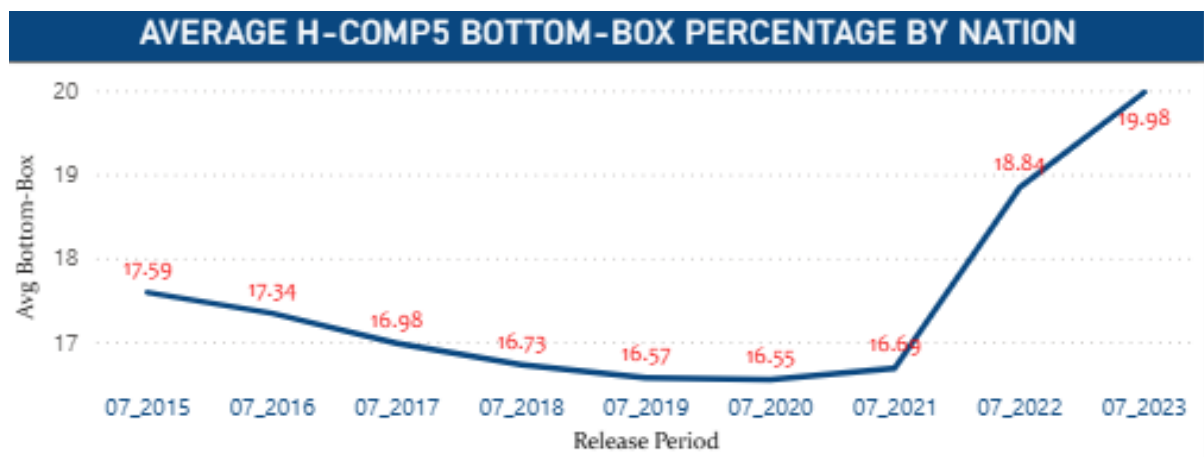
Cụ thể, đối với 6 bang: CA, CT, DC, MA, NJ, NY:

- Trung bình 50-55% bệnh nhân không có phản nản về mức độ ồn
- Trung bình 15-17% bệnh nhân thường xuyên bị làm phiền bởi tiếng ồn, gấp 1.5 lần đánh giá trung bình trên toàn quốc.

Các chỉ số tiêu cực, tích cực và trung bình của 6 bang này tương đối ổn định, ít sự biến động theo thời gian do vậy có thể khẳng định đây là vấn đề đã tồn tại trong một khoảng thời gian dài và chưa có phương pháp xử lý.

2.2 H_COMP_5: Hỗ trợ thông tin toa thuốc





Bảng: Đánh giá sự hỗ trợ về các toa thuốc

Chỉ số Hỗ trợ toa thuốc H_COMP_5 là một trong 3 chỉ số trong 2 năm gần nhất 2021-2023 có sự suy giảm thấy rõ.

-Đánh giá tiêu cực tăng gần 20% từ 16.69 → 19.98

-Đánh giá trung bình tăng nhẹ từ 17.27 → 18.53

Với đánh giá trung bình trên toàn quốc năm bottom 3 và liên tục 2 năm có sự suy giảm, đây là 1 chỉ số rất đáng lưu ý.

Dưới đây là các bang có chỉ số H-COMP5 thấp hơn so với trung bình toàn quốc.

AVG H-COMP5 TOP-BOX BY STATE								
Release Period	CA	DC	FL	GA	MD	NJ	NV	NY
07_2015	62	57	61	64	60	60	59	61
07_2016	61	55	62	64		59	60	60
07_2017	62	56	61	65	60	60	61	61
07_2018	62	58	62	65	60	61	62	61
07_2019	63	58	62	65	61	60	60	61
07_2020	63	59	62	64	61	60	63	60
07_2021	63	59	62	65	61	60	64	60
07_2022	60	58	58	60	57	57	59	59
07_2023	58	53	56	60	56	55	61	56

Bảng: Đánh giá tích cực về chỉ số H-COMP5

AVG H-COMP5 MIDDLE-BOX BY STATE								
Release Period	CA	DC	FL	GA	MD	NJ	NV	NY
07_2015	18	18	17	16	18	18	19	18
07_2016	19	19	17	16		19	18	18
07_2017	18	18	18	16	18	18	19	18
07_2018	18	18	18	16	18	18	18	18
07_2019	18	18	18	16	18	19	19	18
07_2020	18	19	17	18	18	18	18	18
07_2021	18	18	17	17	18	18	18	18
07_2022	18	17	17	18	19	18	18	18
07_2023	19	18	18	18	19	19	17	19

Bảng: Đánh giá trung bình về chỉ số H-COMP5

AVG H-COMP5 BOTTOM-BOX BY STATE								
Release Period	CA	DC	FL	GA	MD	NJ	NV	NY
07_2015	20	25	22	20	22	22	22	21
07_2016	20	26	21	20		22	22	22
07_2017	20	26	21	19	22	22	20	21
07_2018	20	24	20	19	22	21	20	21
07_2019	19	24	20	19	21	21	21	21
07_2020	19	22	21	18	21	22	19	22
07_2021	19	23	21	18	21	22	18	22
07_2022	22	25	25	22	24	25	23	23
07_2023	23	29	26	22	25	26	22	25

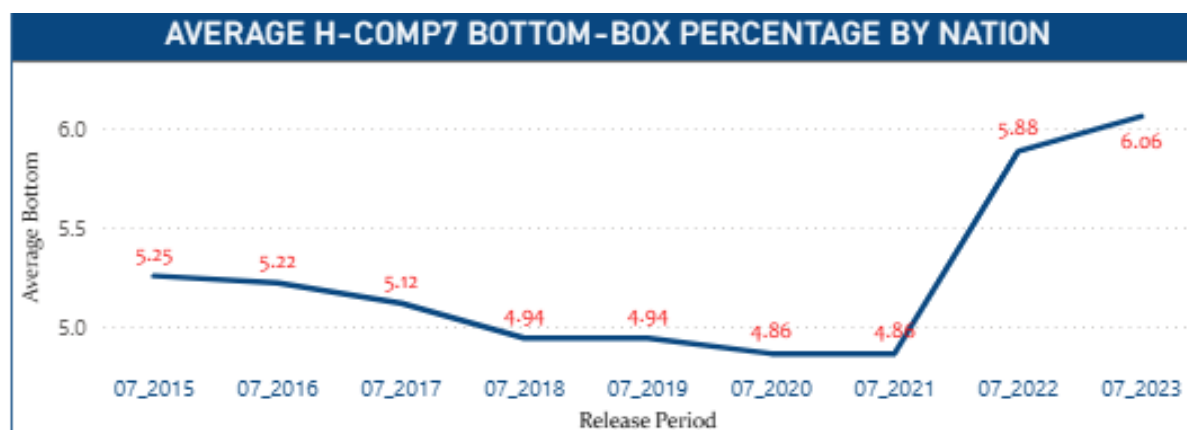
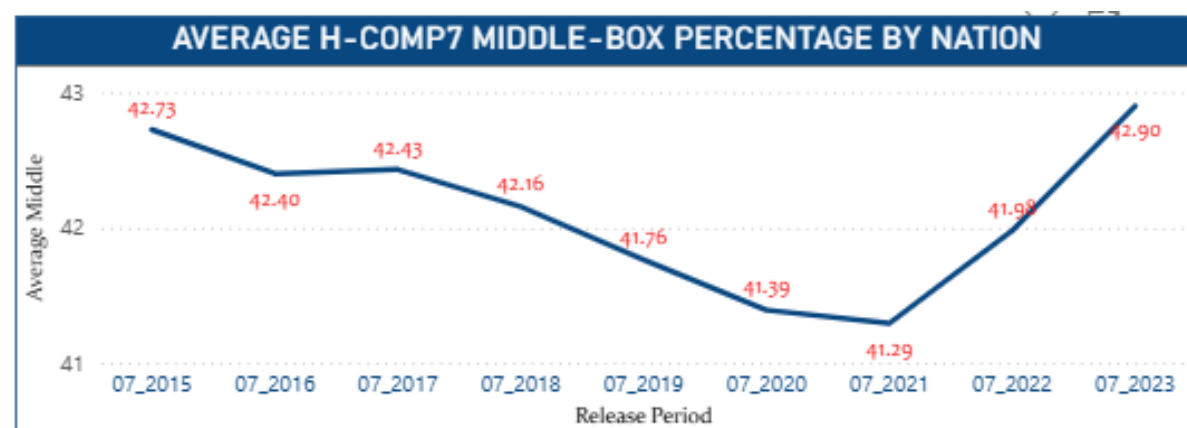
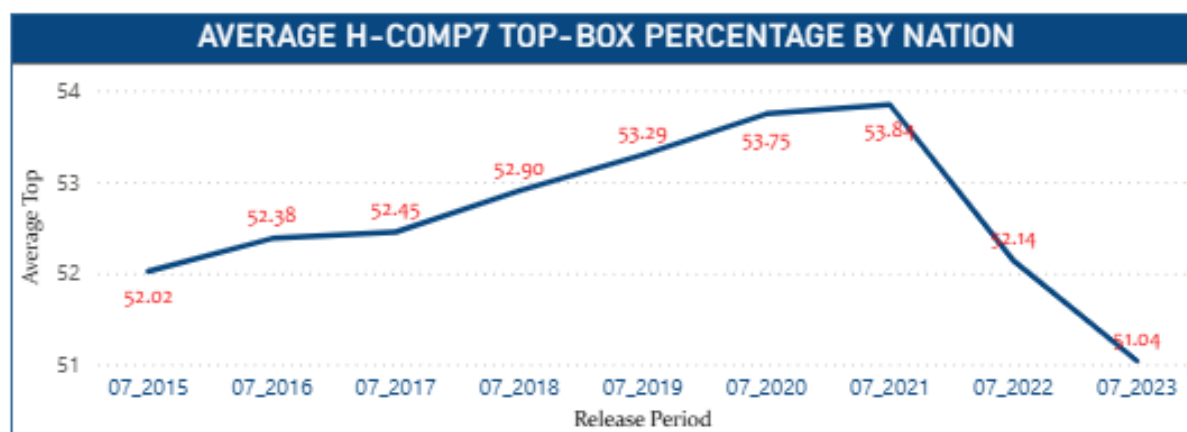
Bảng: Đánh giá tiêu cực về chỉ số H-COMP5

Trong số 50 bang, các bang CA, DC, FL, GA, MD, NJ, NV, NY là các bang bị đánh giá chỉ số H-COMP5 tệ hơn mức trung bình toàn quốc.

Các đánh giá tiêu cực của 8 bang này đều đang có xu hướng gia tăng từ 2015-2023. Trong đó tệ nhất là 2 bang DC (29) và NJ (26)

Các đánh giá trung bình hầu như không có sự thay đổi, vậy nên đối với H-COMP5 chỉ có sự dịch chuyển từ đánh giá tích cực → đánh giá tiêu cực.

2.3 H_COMP_7: Hỗ trợ thông tin khi xuất viện/chuyển viện



Chỉ số Hỗ trợ thông tin khi xuất viện H-COMP7 là chỉ số đứng cuối cùng trong đánh giá của bệnh nhân về dịch vụ của cơ sở y tế, trung bình chỉ đạt 52-54% nhận xét tích cực, và còn đang có xu hướng giảm trong 2022-2023

AVG H-COMP7 TOP-BOX BY STATE				
Release Period	CA	DC	FL	NV
07_2015	49	42	49	47
07_2016	48	42	49	47
07_2017	49	43	50	45
07_2018	49	44	50	49
07_2019	49	45	50	47
07_2020	50	46	51	51
07_2021	50	47	51	52
07_2022	47	48	48	47
07_2023	47	45	47	47

Bảng: Đánh giá tích cực H-COMP7

AVG H-COMP7 MIDDLE-BOX BY STATE				
Release Period	CA	DC	FL	NV
07_2015	44	49	44	46
07_2016	45	49	44	45
07_2017	44	48	43	47
07_2018	44	47	43	43
07_2019	44	47	43	45
07_2020	44	45	42	42
07_2021	44	44	42	41
07_2022	45	44	43	44
07_2023	45	46	44	44

Bảng: Đánh giá trung bình H-COMP7

AVG H-COMP7 BOTTOM-BOX BY STATE				
Release Period	CA	DC	FL	NV
07_2015	7	9	7	7
07_2016	7	9	7	8
07_2017	7	9	7	8
07_2018	7	9	7	8
07_2019	7	8	7	8
07_2020	6	9	7	7
07_2021	6	9	7	7
07_2022	8	8	9	9
07_2023	8	9	9	9

Bảng: Đánh giá tiêu cực H-COMP7

Chỉ số H-COMP7 là chỉ số hơi khác so với H-COMP3 hay chỉ số tiếng ồn. Với H-

COMP7 đánh giá nằm chủ yếu ở mức độ trung bình – tích cực. Các chỉ số tiêu cực gần như không thay đổi quá nhiều và luôn nằm ở mức < 10%.

Đối với H-COMP7, 4 bang đang nằm dưới mức trung bình quốc gia là: CA, DC, FL, NV. Tuy nhiên, cả 3 chỉ số của H-COMP7 ở 4 bang này đều tương đối ổn định qua các năm, đây là dấu hiệu của 1 vấn đề đã tồn tại từ lâu và chưa có phương án xử lý triệt để.

GIẢI PHÁP – ĐỀ XUẤT

1. Đề xuất phương án quy mô quốc gia.

Đối với quy mô quốc gia, hiện tại đang có 2 vấn đề nổi bật:

1. Số lượng cơ sở y tế tham gia khảo sát và số lượng phản hồi của từng cơ sở đang giảm đáng kể. Riêng số lượng phản hồi của bệnh nhân đã giảm đến 30% chỉ trong 7 năm (3.1tr lượt → 2.2tr lượt) Đây là tín hiệu rất xấu, vì nếu dữ liệu không đủ sẽ dẫn tới đánh giá bị thiên lệch hoặc không chính xác.

*Giải pháp:

- Tập trung vào các bang đang có tỉ lệ response thấp (dưới 500). Có thể chia nhỏ giai đoạn nếu cần thiết:

Giai đoạn 1: Các bang có tỉ lệ từ 0-200 (ưu tiên mức độ 1)

Giai đoạn 2: Các bang có tỉ lệ từ 200-500 (ưu tiên mức độ 2)

Giai đoạn 3: các bang có response >500 nhưng đang trên đà giảm mạnh (vd: RI giảm 40%)

*Lưu ý: Có thể tiến hành 1 khảo sát nhỏ đối với các bang đang làm rất tốt (>1000 responses) để đóng gói quy trình và triển khai tại các bang làm kém.

2. Các chỉ số đo lường trong 2 năm gần nhất từ 2021-2023 đều đang có xu hướng giảm nhẹ (9/10 chỉ số) Trên quy mô toàn quốc, đây là 1 vấn đề nên được lưu ý vì nó chứng tỏ chất lượng dịch vụ có thể đang đi xuống từ từ ở tất cả các khía cạnh.

*Giải pháp:

-Theo dõi thêm ít nhất 1-2 năm nữa, nếu tình trạng vẫn tiếp diễn thì các cơ sở y tế trên toàn quốc sẽ cần được đào tạo bồi dưỡng ở khía cạnh dịch vụ chăm sóc bệnh nhân.

-Trong thời gian tiếp tục theo dõi, rất nên đề xuất bộ Y tế cung cấp 1 bộ quy chuẩn về cung cấp dịch vụ tại các cơ sở y tế. Nếu các chỉ số đo lường tiếp tục giảm trong 1-2 năm tới, hãy đào tạo đồng loạt toàn bộ cơ sở y tế trên toàn quốc.

2.Đề xuất phương án quy mô các bang

Đối với quy mô từng bang, đề xuất sẽ được dựa trên 3 chỉ số bottom: H-COMP5, H-COMP7, QUIET tương ứng với các bang.

1.Đối với H-COMP5:Hỗ trợ thông tin toa thuốc

***Giải pháp:**

-Tập trung xử lý ưu tiên các bang đang có chỉ số thấp hơn mức trung bình toàn quốc là: CA, DC, FL, GA, MD, NJ, NV, NY đặc biệt là 2 bang thấp nhất: DC và NJ.

-Cung cấp thông tin toa thuốc từ trước đến giờ có thể là trách nhiệm của dược sĩ, nhân viên quầy thuốc. Sau khi thăm khám, điều trị, bệnh nhân sẽ được kê đơn thuốc và có thể mua thuốc tại bệnh viện hoặc các hiệu thuốc bên ngoài. Do vậy, các dược sĩ sẽ không thể nắm hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân để hiểu rõ tác dụng phụ cũng như vì sao phải uống thuốc. Đây là điểm vướng mắc trong quy trình kê đơn của bệnh viện.

-Việc hỗ trợ thông tin về toa thuốc có thể đưa vào trách nhiệm của y tá hoặc bác sĩ vì trong thời gian nằm viện đây là 2 nhân sự biết rõ nhất tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân cũng như có kiến thức về y, dược tương đối tốt.

Thêm vào đó, chỉ số tương tác với y tá, bác sĩ là 2 chỉ số đang được đánh giá tốt nhất. Nếu như bác sĩ hay y tá có thể cung cấp thêm thông tin về toa thuốc, thì bệnh nhân sẽ vô tình được cá nhân hoá dịch vụ y tế: từ thăm khám, tư vấn, chăm sóc và tư vấn thuốc, tất cả sẽ đều do 1 bác sĩ/y tá theo dõi.

Ngoài ra, bệnh viện hoàn toàn có thể lấy thông tin số điện thoại, email của bệnh nhân và gửi thông tin về toa thuốc sau khi xuất viện. Điều này sẽ giúp bệnh nhân và người nhà có thể tự mình dùng thuốc mà không cần gọi hỗ trợ.

2. Đối với H_QUIET_HSP: Mức độ ồn tại bệnh viện

Đối với tiêu chí mức độ ồn tại bệnh viện vào ban đêm, cần xác định rõ nguyên nhân: Đây là nguồn gốc của tiếng ồn.

- Nếu tiếng ồn xuất phát từ chính hoạt động trong viện, thì cần ban hành các quy định về hành xử, hoạt động gây ra tiếng ồn lớn vào ban đêm: nói chuyện, bật nhạc, cười đùa ... và áp dụng lên tất cả nhân viên và bệnh nhân đang trong bệnh viện. Có thể gắn thêm các biển cấm gây ồn ào ở các khu vực nội trú cho bệnh nhân.

- Nếu tiếng ồn xuất phát từ bên ngoài bệnh viện, lúc này, người đứng đầu cơ sở cần liên lạc với chính quyền sở tại để xin hỗ trợ các phương án làm giảm bớt tiếng ồn vào ban đêm để cho bệnh nhân được nghỉ ngơi. Có thể đề xuất không bật nhạc, ca hát, bấm còi ... trong bán kính 50m xung quanh bệnh viện.

- Các bang đang bị phản ánh có mức độ ô nhiễm tiếng ồn lớn: CA, CT, DC, MA, NJ, NY

***Giải pháp:**

- Cần 1 cuộc khảo sát nhỏ của tất cả các cơ sở y tế để xác định nguồn gốc của tiếng ồn bị bệnh nhân phản ánh. Có thể hỏi trực tiếp bệnh nhân hoặc lấy ý kiến của cả bệnh nhân lẫn các nhân sự trực ca đêm để tăng độ chính xác.

- Sau khi khảo sát xong và xác định nguyên nhân gây ồn đến từ bên trong/ngoài bệnh viện, hãy áp dụng 1 trong 2 phương án đề xuất bên trên.

3. Đối với H_COMP_7: Hỗ trợ thông tin khi xuất viện/chuyển viện

Các thông tin khi xuất viện/chuyển viện là 1 vấn đề phức tạp, tuy nhiên trong phạm vi câu hỏi chỉ đề cập về nội dung xoay quanh câu hỏi: Liệu bệnh nhân sau khi xuất viện có hiểu rõ tình trạng bệnh của mình để có phương pháp chăm sóc, điều trị phù hợp không? Và chỉ có 50% bệnh nhân hiểu rõ mình cần làm gì để chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

***Giải pháp:**

- Kết hợp với giải pháp hỗ trợ thông tin về toa thuốc, các thông tin về tình trạng bệnh lý, hướng dẫn chăm sóc sau khi xuất viện nên được tư vấn bởi chính bác sĩ đang điều trị cho người bệnh. Khi chuẩn bị xuất viện, bác sĩ trực tiếp điều trị sẽ hướng dẫn, giải thích cho bệnh nhân tình trạng bệnh, cách chăm sóc tại

nhà cũng như thông tin chi tiết về toa thuốc, hướng dẫn sử dụng.

Có đến 2/ 3 tiêu chí được đánh giá thấp nhất là về thông tin sau khi xuất viện: thông tin về đơn thuốc, thông tin về tình trạng bệnh. Những thông tin này hoàn toàn có thể được tư vấn rõ ràng bởi bác sĩ trực tiếp điều trị và cũng là 1 cách để khép kín quy trình từ thăm khám, điều trị cho đến khi bệnh nhân xuất viện.

Có thể hỗ trợ bệnh nhân thêm bằng cách gửi thông tin cần thiết qua email cá nhân, số điện thoại ... nếu cần thiết.

KẾT LUẬN

Qua phần báo cáo, phân tích về data-set của “HCAHPS (2013–2022) – bộ khảo sát trải nghiệm bệnh nhân tại Mỹ” chúng ta đã có được 1 góc nhìn về chất lượng dịch vụ của các cơ sở y tế tại Mỹ do chính bệnh nhân đánh giá. Báo cáo cũng nói lên thực trạng dịch vụ y tế Mỹ đang có dấu hiệu đi xuống và ngay cả tại các cơ sở y tế điều này cũng không được quan tâm nhiều. Vậy nên cần có những biện pháp cụ thể có thể triển khai ngay. Các giải pháp từ cấp độ quốc gia cho đến từng bang đã được gợi ý ở phần báo cáo và phân tích phía trên, tuy nhiên sẽ còn phụ thuộc vào nguồn lực hiện có của từng bang, từng cơ sở y tế.